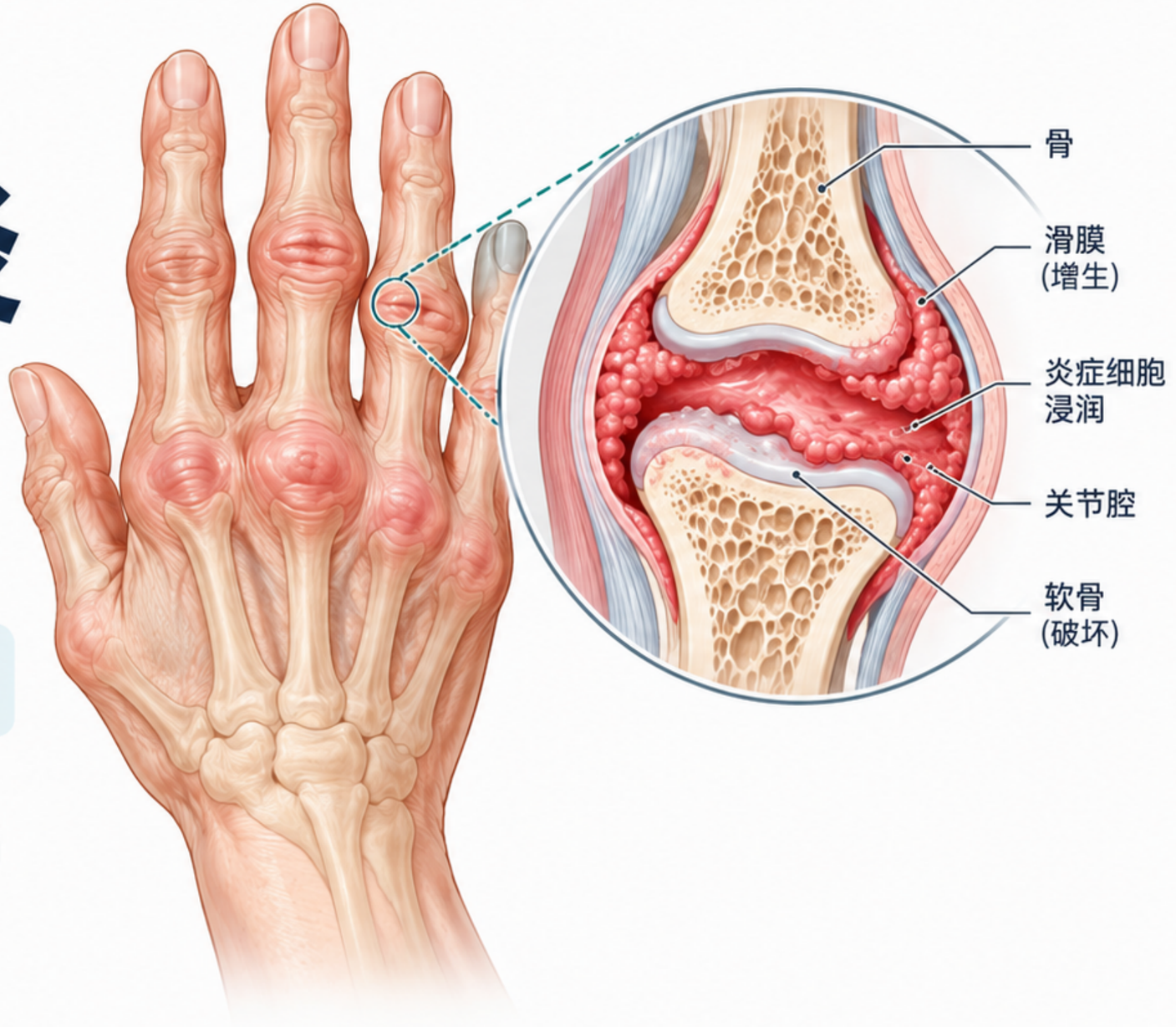
类风湿关节炎

Rheumatoid Arthritis · RA

临床医学本科四年级《内科学》

识别 → **诊断** → **治疗**

主要依据：《内科学》第10版及所提供讲稿



病例导入：双手肿痛3个月

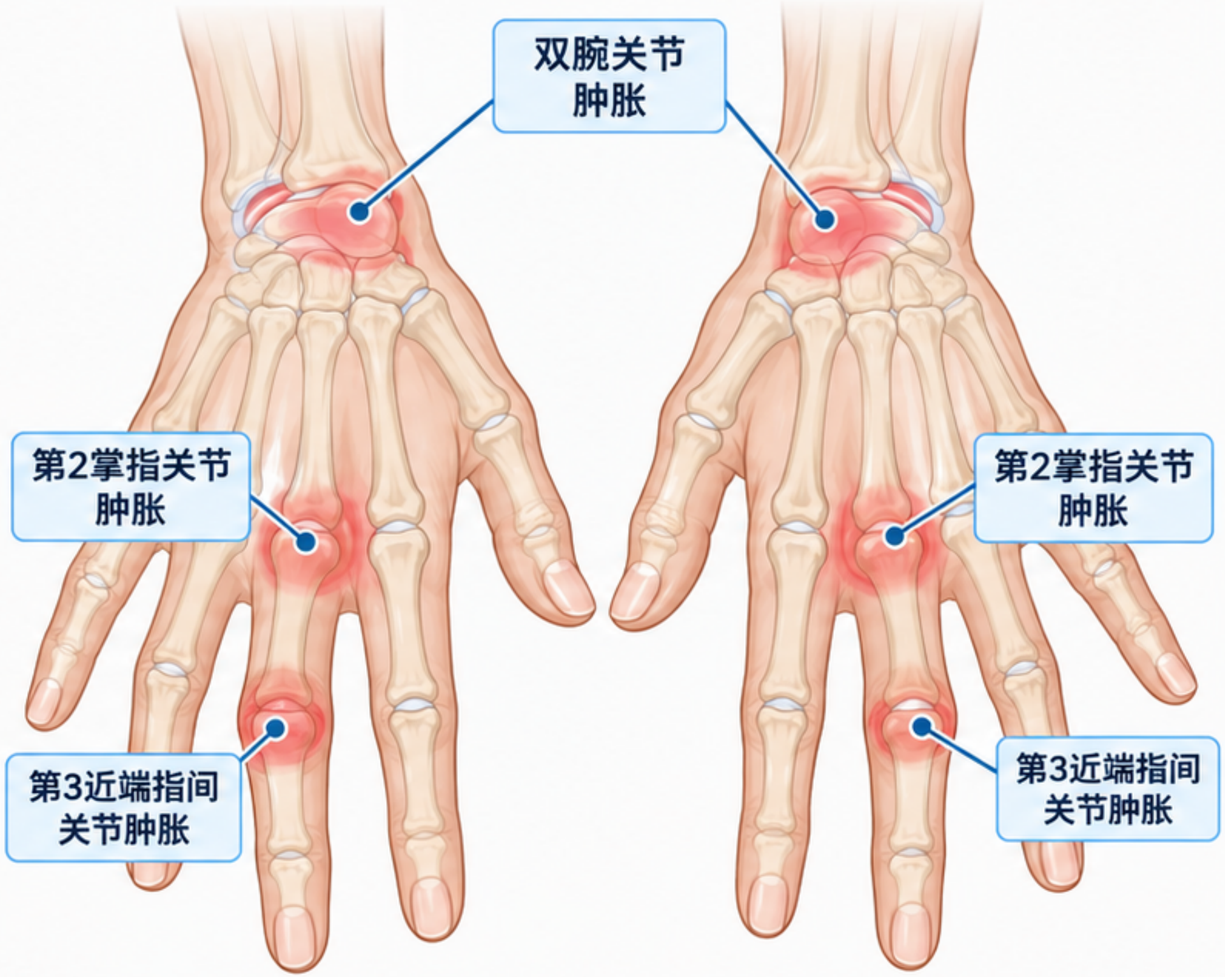
教学模拟病例 | 女性，48岁

- 双手及双腕对称性肿痛；晨僵约90'分钟
- 双腕、双侧第2掌指及第3近端指间关节肿胀，共6个小关节

课堂讨论：

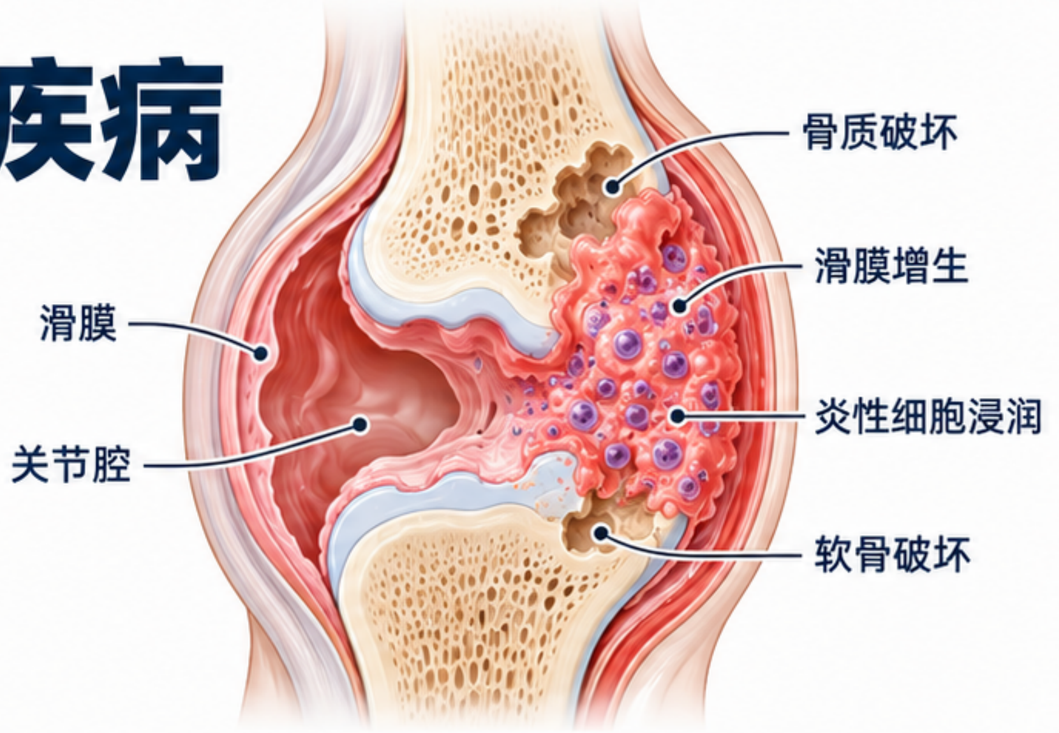
炎性还是机械性？

下一步查什么？

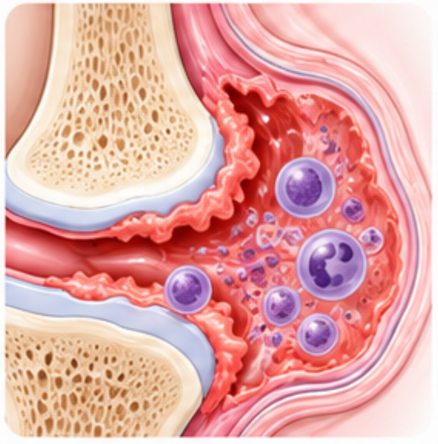


RA：从滑膜炎到全身性疾病

- 慢性、**全身性**自身免疫性疾病
- 以**侵蚀性、对称性**多关节炎为主要表现
- 女性约为男性**2～3**倍；**35～50**岁较常见
- 我国总患病率约**0.42%**（据所提供教材讲稿）



1 滑膜炎：免疫介导的慢性炎症

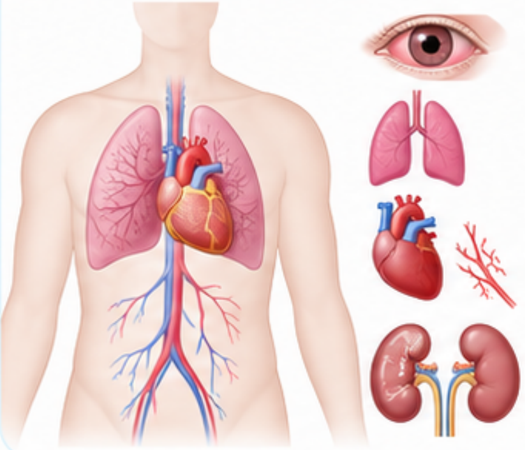


滑膜持续炎症，炎性细胞浸润和滑膜增生，形成肉芽组织，破坏关节结构。

2 关节破坏：侵蚀性、对称性多关节炎

以侵蚀性、对称性多关节炎为主要表现，可导致关节软骨和骨质破坏，造成关节畸形和功能障碍。

3 关节外受累：累及多器官系统



可累及多器官系统，出现关节外受累，表现为肺、心血管、血管、肾脏、眼等多系统损害。

病因：遗传易感与环境共同作用

遗传：

HLA-DRB1等易感因素

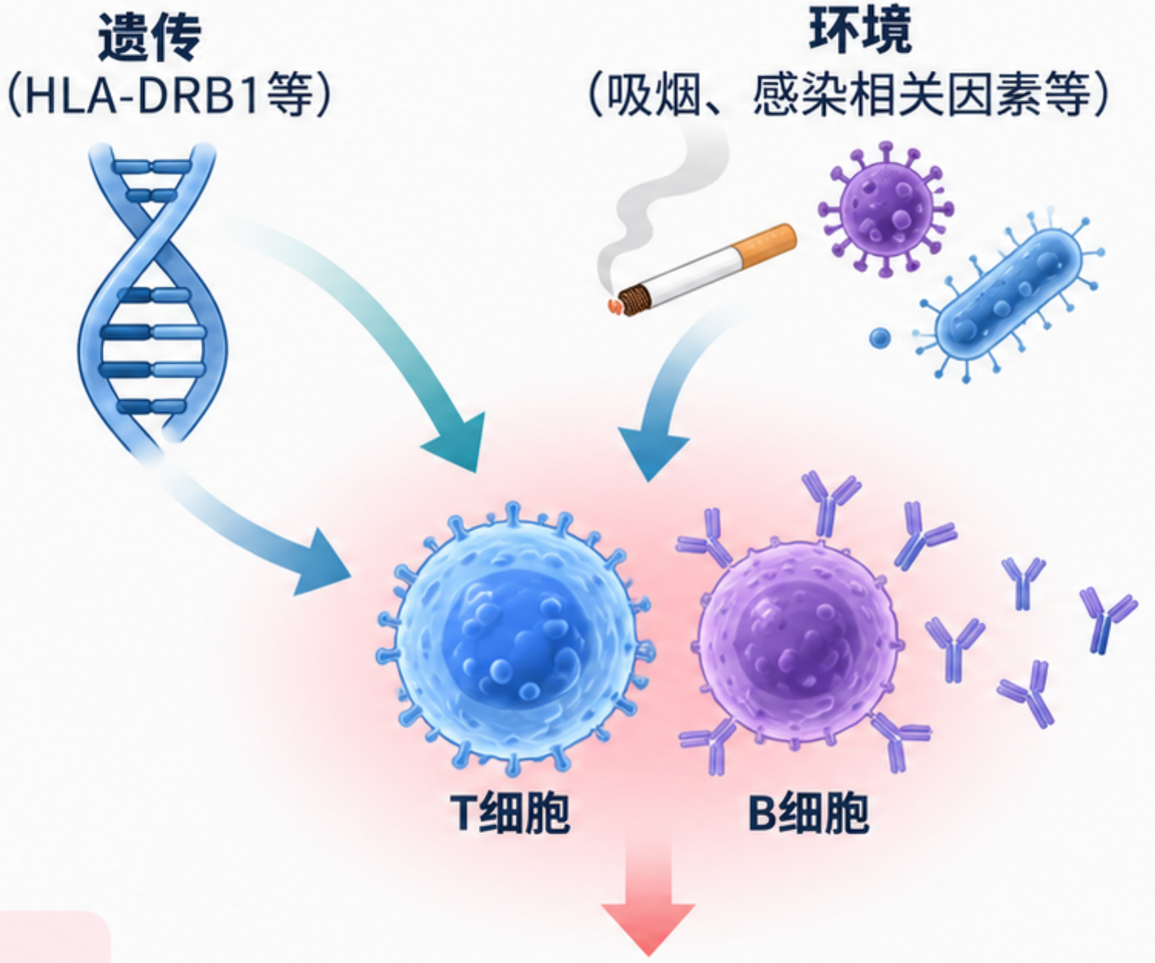
环境：

吸烟、感染相关因素等

免疫：

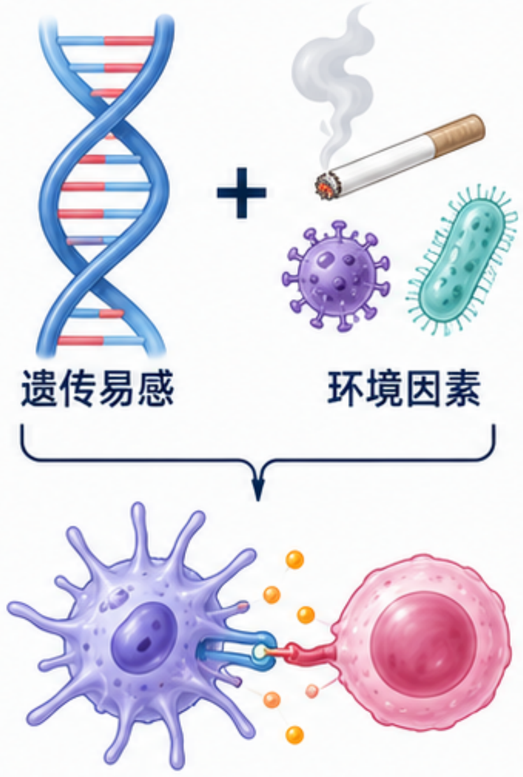
T细胞、B细胞异常活化

易感不等于必然发病；
不能归因于某一种确定致病菌

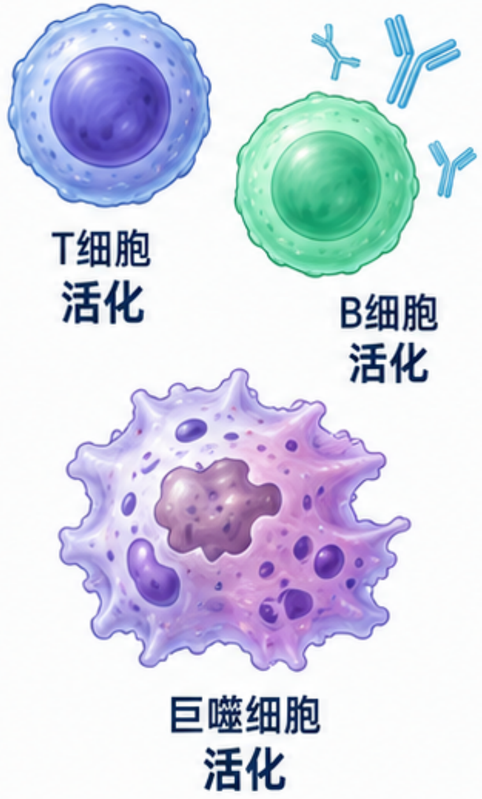


免疫异常如何导致关节破坏？

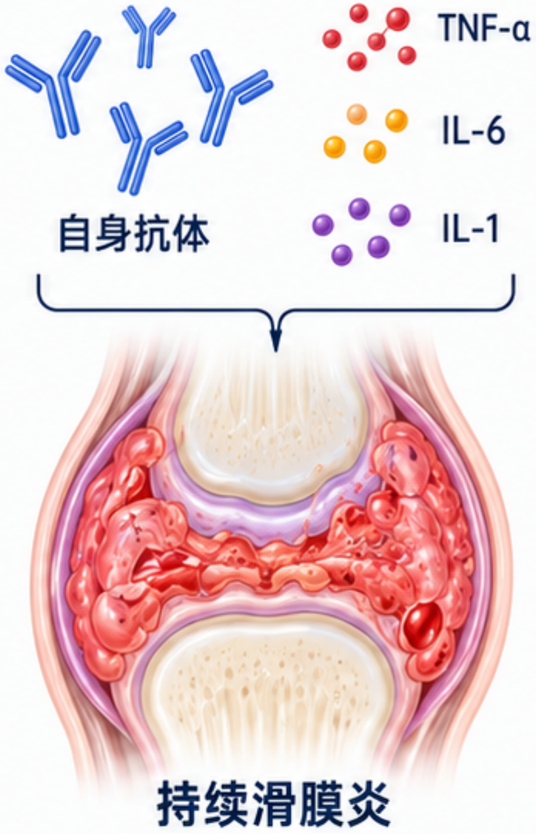
1 遗传易感+环境因素 → 免疫耐受异常



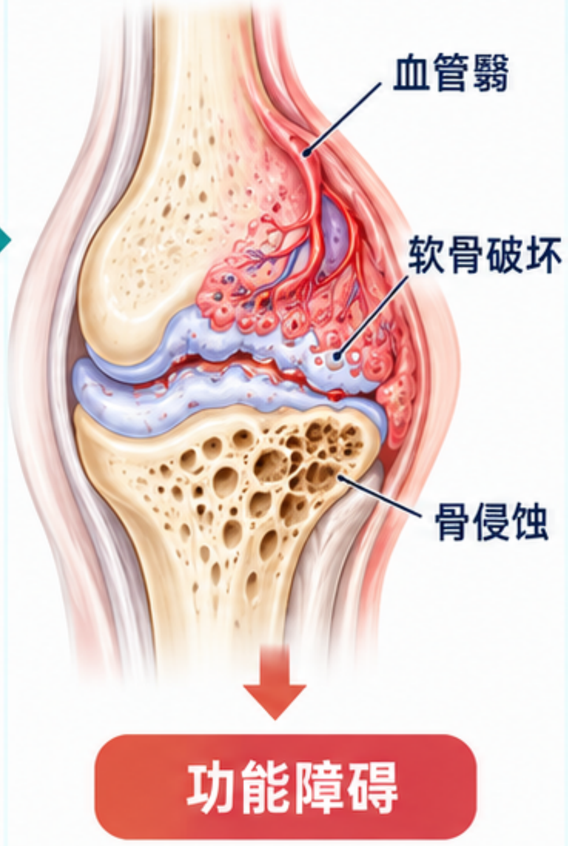
2 T细胞、B细胞、巨噬细胞活化



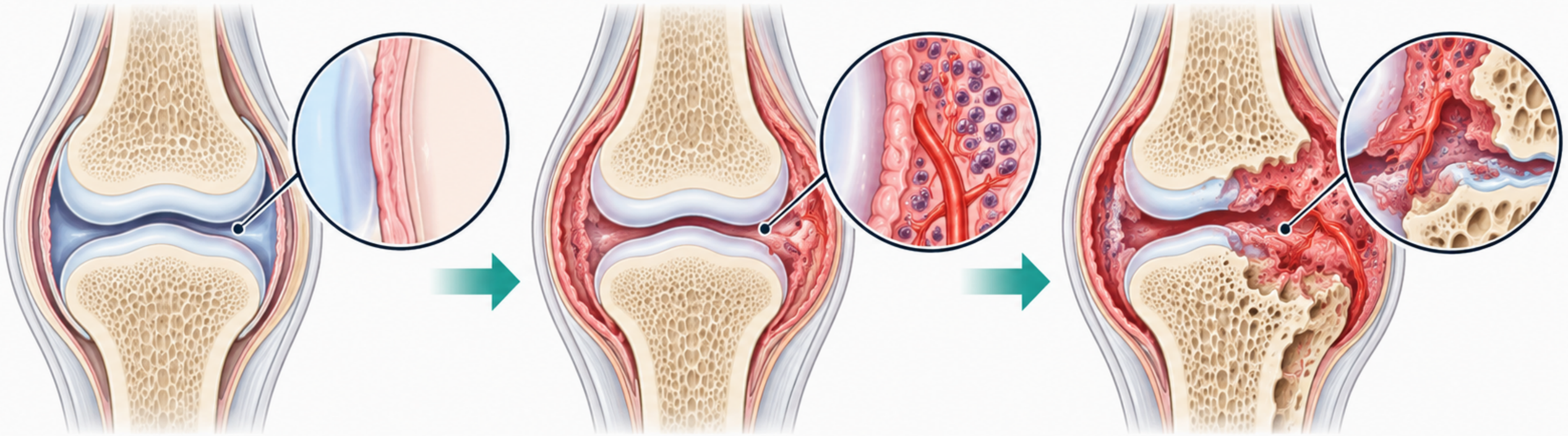
3 自身抗体与TNF-α、IL-6、IL-1等 → 持续滑膜炎



4 血管翳 → 软骨破坏、骨侵蚀 → 功能障碍



核心病理：慢性增生性滑膜炎



- **正常关节：**滑膜薄，软骨完整
- **滑膜炎：**滑膜增厚、炎细胞浸润、新生血管
- **结构损伤：**血管翳侵袭，软骨破坏与骨侵蚀

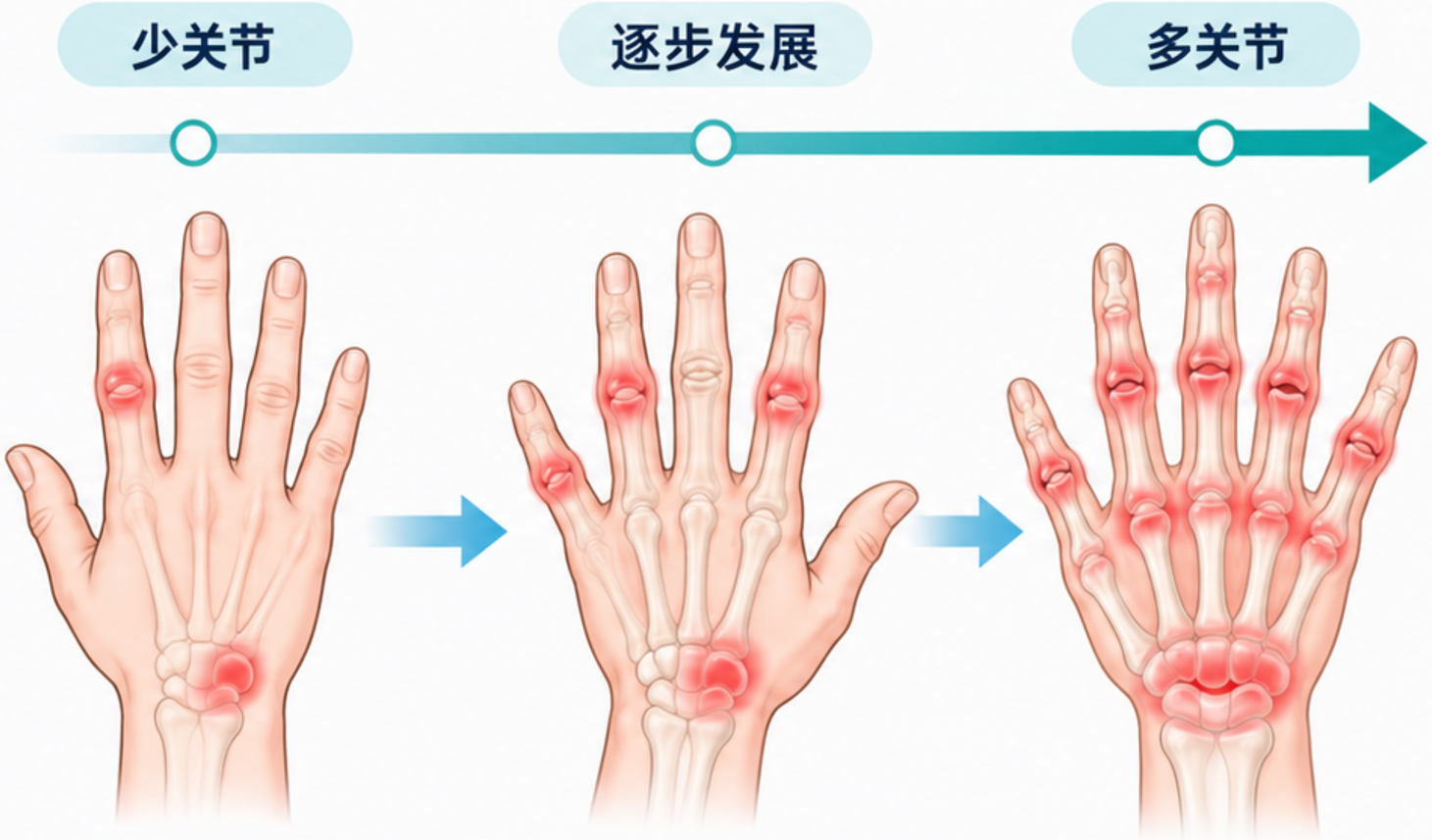
起病常隐匿，需动态观察

乏力、低热、食欲减退等可先出现

腕、掌指、近端指间关节常受累

可从少关节逐步发展为多关节

持续关节肿胀，应动态评估



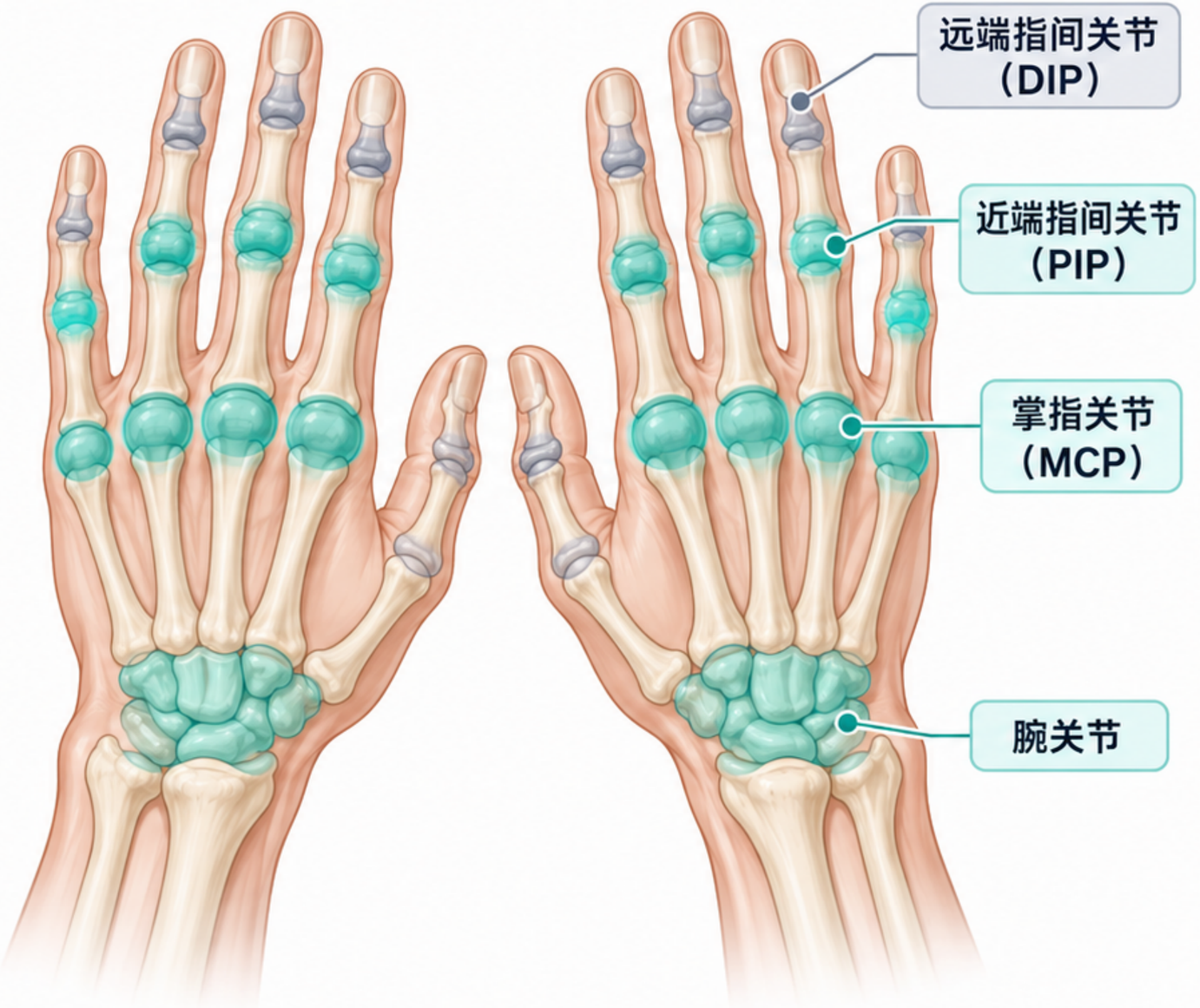
识别典型炎性小关节炎

晨僵： 常 > 30分钟，
活动后减轻

肿胀、压痛、活动受限，
多呈**对称性**

常见： 腕、掌指、近端指间
关节；远端指间非典型
主要部位

非典型分布或晨僵较短，
仍**不能排除RA**

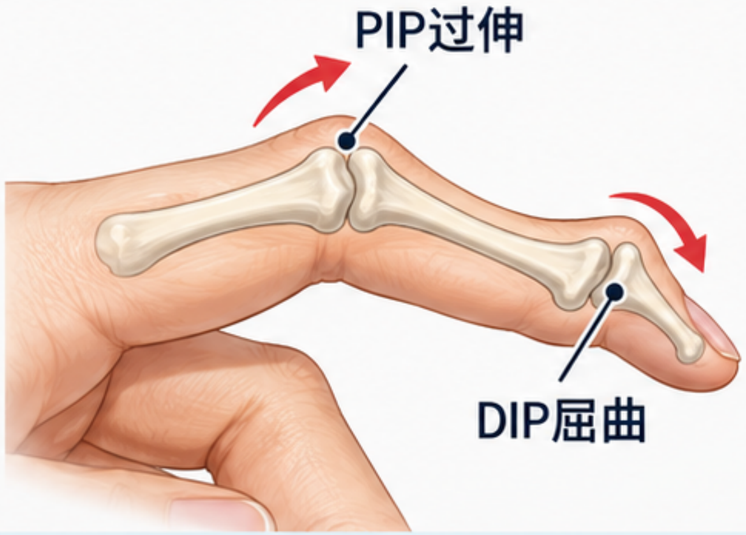


晚期畸形：屈伸方向要分清

尺侧偏斜

尺侧偏斜：掌指关节处向尺侧偏移

天鹅颈



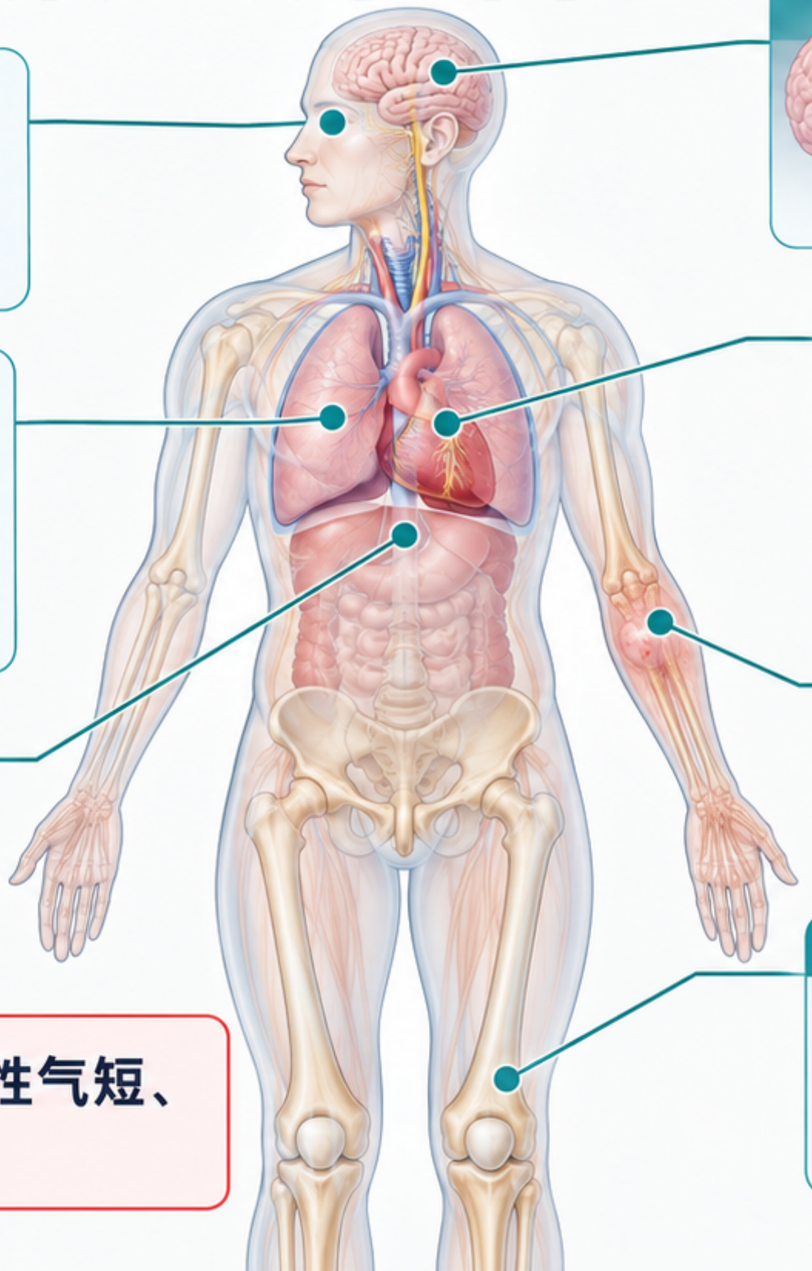
天鹅颈：PIP过伸，DIP屈曲

纽扣花

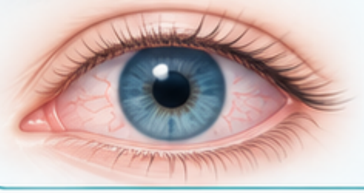
纽扣花：PIP屈曲，DIP过伸

畸形不是早期诊断必要条件

关节之外：必须做全身评估



眼



干眼、
巩膜炎

肺

间质性肺疾病、
胸膜病变、
肺结节

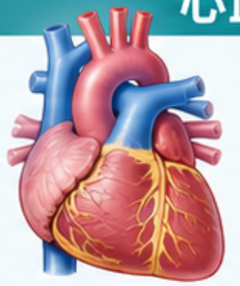
血液

贫血、
Felty综合征

神经

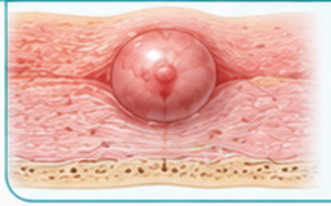
周围神经受累

心血管



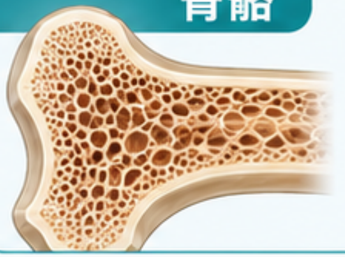
心包炎、
风险增加

皮肤



类风湿结节

骨骼

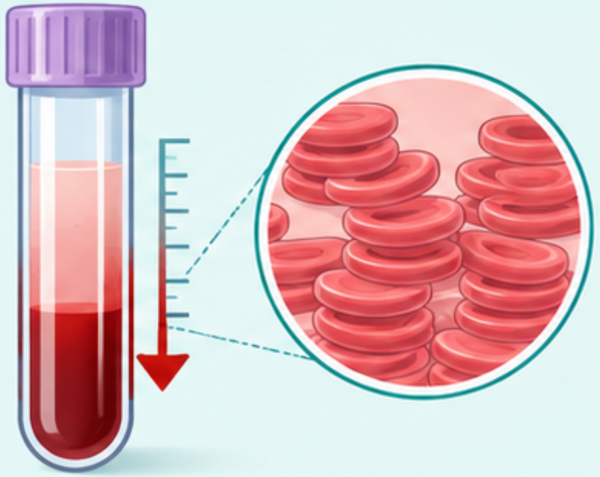


骨质疏松

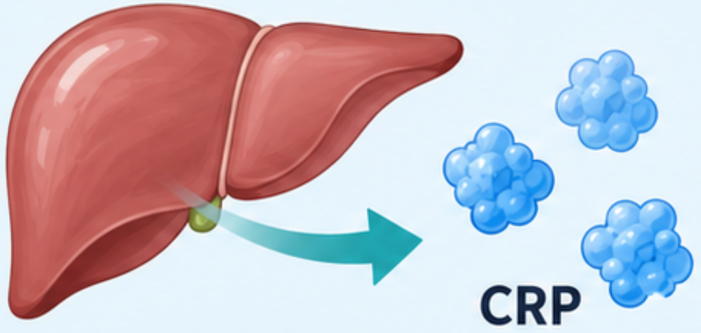
讨论： 关节症状轻 + 进行性气短、能否判断病情轻？

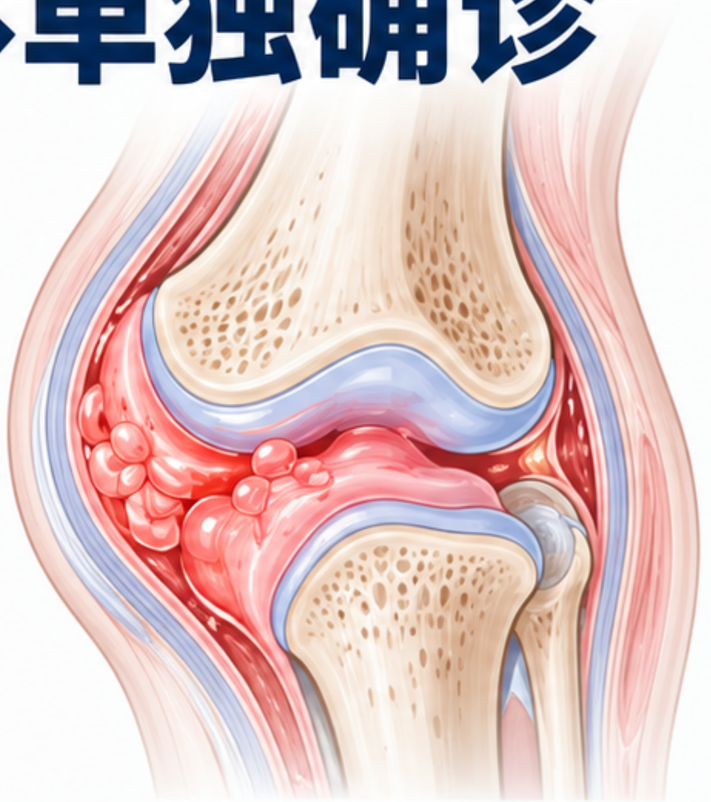
ESR与CRP：反映炎症，不单独确诊

ESR：红细胞沉降率



CRP：C反应蛋白





用途：辅助评估炎症活动，监测治疗反应

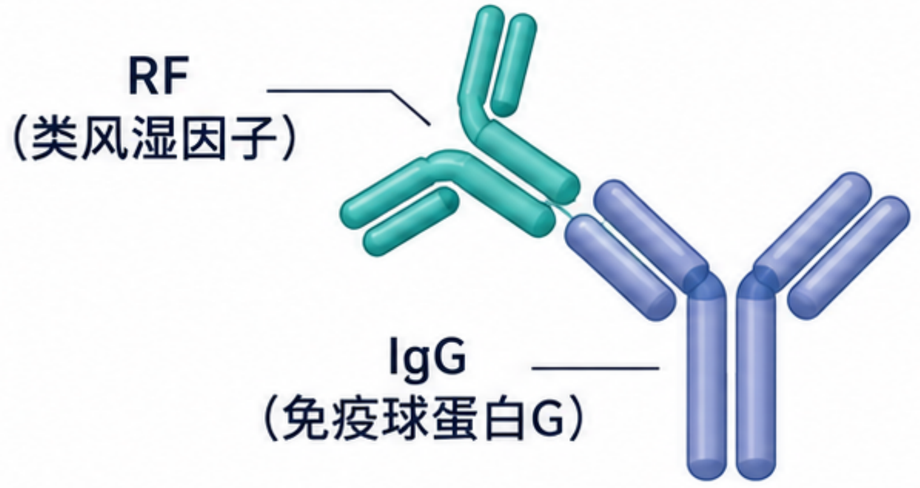
血常规、肝肾功能及必要时关节液检查

- **升高**并非RA特异；
- **正常**也不能排除早期RA

RF与抗CCP：结合临床解释

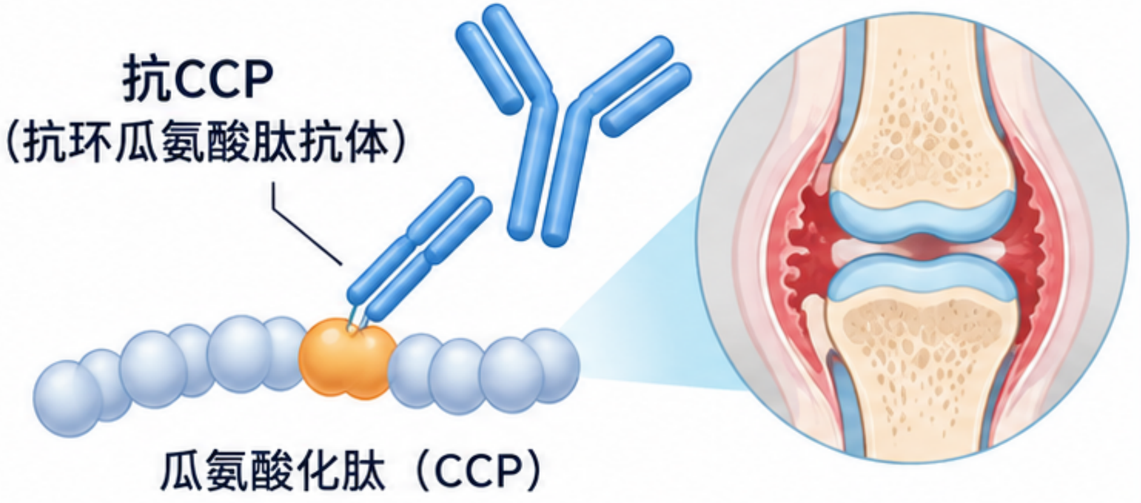
RF

常见自身抗体，特异性有限



抗CCP

属于ACPA，诊断特异性通常较高



思考：

阳性不等于RA；阴性不排除RA

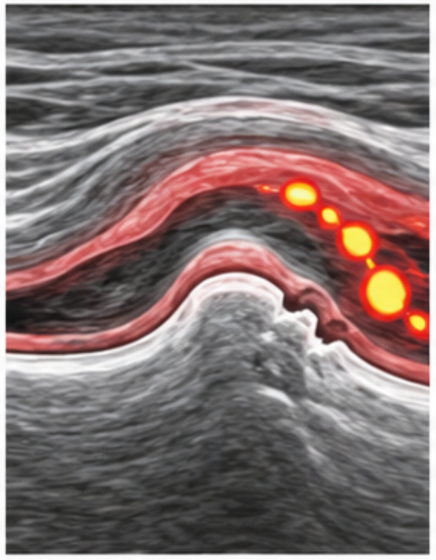
RF阳性，但没有滑膜炎，能否直接诊断？

影像学：寻找炎症与结构损伤

X线

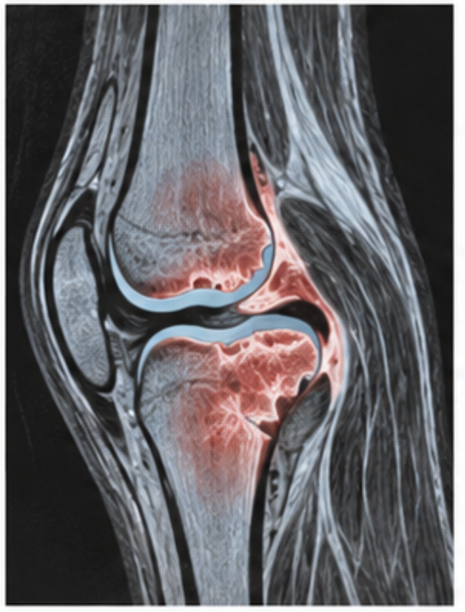
- 软组织肿胀
- 关节周围骨质疏松
- 后期间隙变窄、骨侵蚀

超声



- 滑膜增厚
- 积液
- 血流信号
- 部分骨侵蚀

MRI

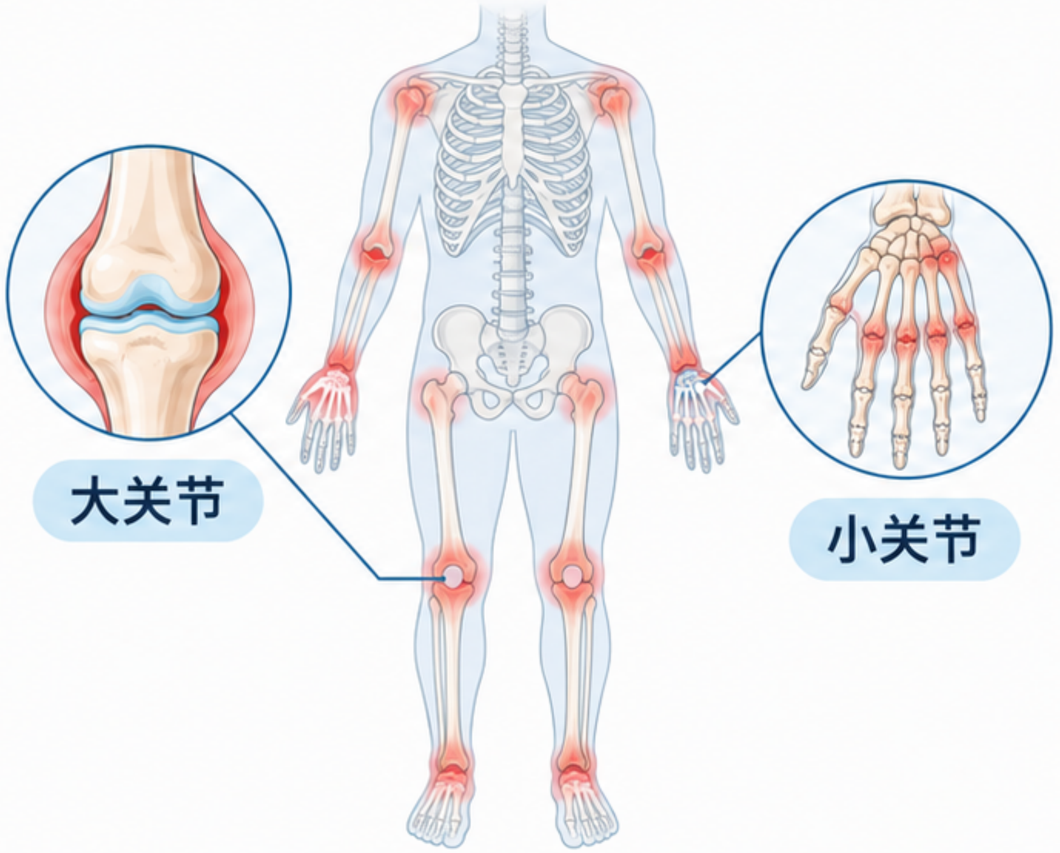


- 早期滑膜炎
- 骨髓水肿
- 骨侵蚀

早期X线无侵蚀不排除RA；并非人人需要MRI

2010 ACR/EULAR：先确认适用条件

前提：≥1个关节有明确临床滑膜炎；无其他更合理解释



关节受累评分：	
1个大关节	0分
2～10个大关节	1分
1～3个小关节	2分
4～10个小关节	3分
＞10个关节且含≥1个小关节	5分

四维计分：总分≥6分符合分类标准

1 血清学

RF及ACPA均阴性	0分
任一低滴度阳性	2分
任一高滴度阳性	3分

2 病程

< 6周	0分
≥ 6周	1分

3 急性期反应物

CRP及ESR均正常	0分
任一异常	1分

低滴度：>正常上限且≤3倍

高滴度：>3倍

总分
满分10分

≥6分
符合分类标准

血清学仅计一次。
分类标准不能替代临床诊断。

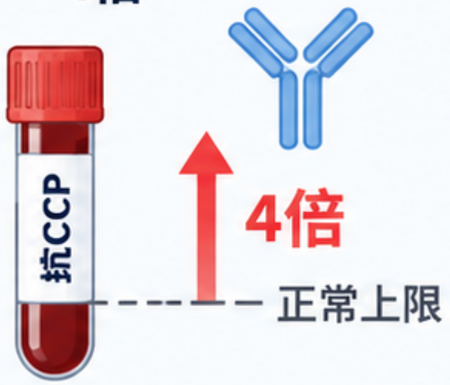
病例评分：请先独立计算

1 6个小关节滑膜炎

3分

+

2 抗CCP为正常上限4倍



3分

+

3 症状3个月

1分

+

4 CRP升高

1分

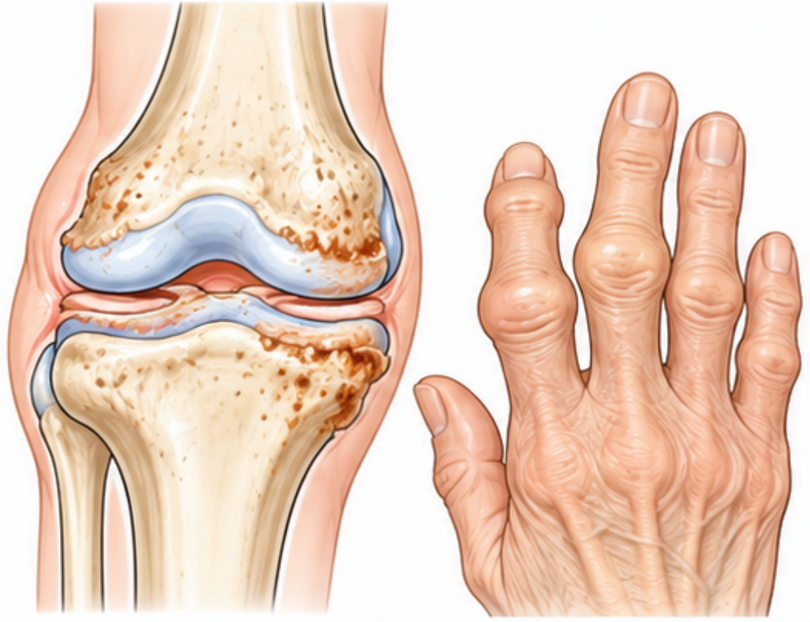
合计：3 + 3 + 1 + 1 = 8分

无其他更合理病因时，结合临床高度支持RA

鉴别诊断：先看关节炎的模式

骨关节炎

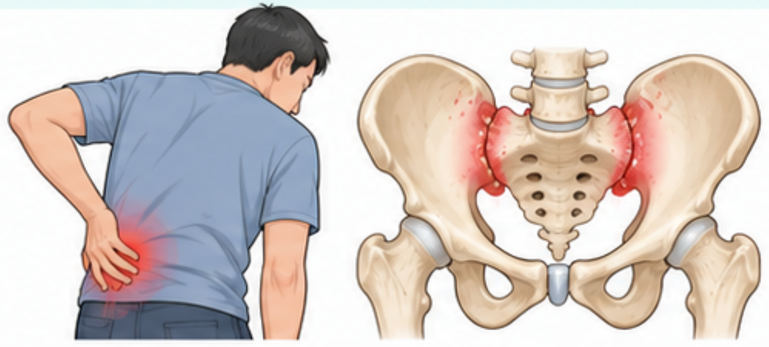
机械性痛、短晨僵、骨性膨大



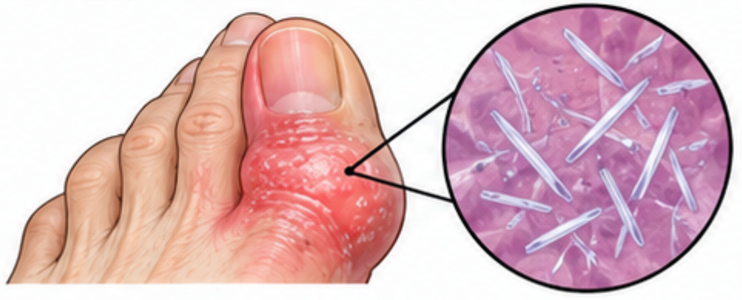
SLE：多系统表现

银屑病关节炎： 皮损、指炎、甲改变

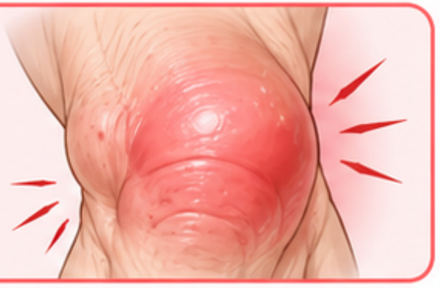
脊柱关节炎：炎性腰背痛、骶髂关节炎



痛风：急性发作、晶体



急性红肿热痛＋发热：警惕感染性关节炎



持续评估，才能调整治疗

1. 常用评估指标

常用：DAS28、CDAI、SDAI

2. 判断疾病活动度

判断：缓解、低度、中度或高度活动

- 缓解
- 低度活动
- 中度活动
- 高度活动

3. 全面评估疾病影响

同时评估功能、影像进展、关节外受累和生活质量

4. 评估的目的

评分的目的：
指导治疗，
而非只得到一个数字

早期DMARDs＋持续达标管理

目标： 持续临床缓解或低疾病活动度

保护关节结构、功能与生活质量

早期规范治疗，DMARDs是核心

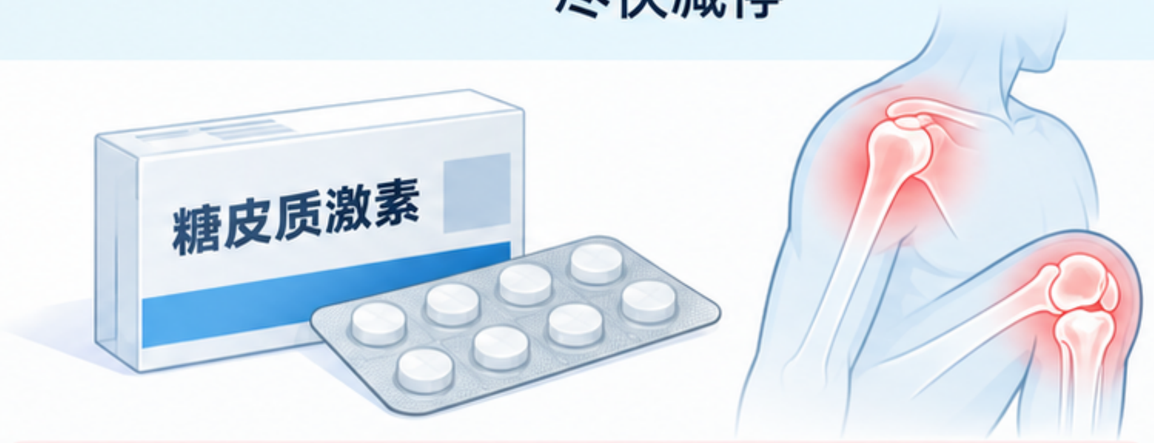
评估 → 治疗 → 随访 → 按活动度与安全性调整

NSAIDs与激素：缓解症状需控制风险

NSAIDs： 如布洛芬、塞来昔布；
改善疼痛与炎症

注意胃肠道、肾脏及心血管风险

糖皮质激素： 适当患者短期应用，
尽快减停



关注感染、血糖及骨质疏松

⚠ 两者均不能替代DMARDs

传统合成DMARDs：治疗基础

甲氨蝶呤（MTX）

常用初始策略的核心药物之一

来氟米特、柳氮磺吡啶、羟氯喹：按病情选择或联合

来氟米特

柳氮磺吡啶

羟氯喹

MTX用于RA通常每周给药，不是每日

监测血常规与肝肾功能；关注妊娠风险及叶酸补充

靶向治疗：疗效与安全并重

生物DMARDs

TNF-α抑制剂、
IL-6通路抑制剂等

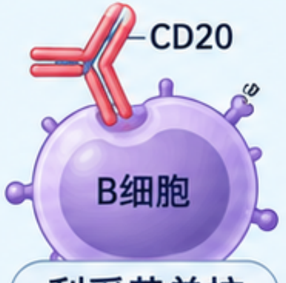
TNF-α抑制剂

IL-6通路抑制剂

其他机制

阿巴西普、
利妥昔单抗等

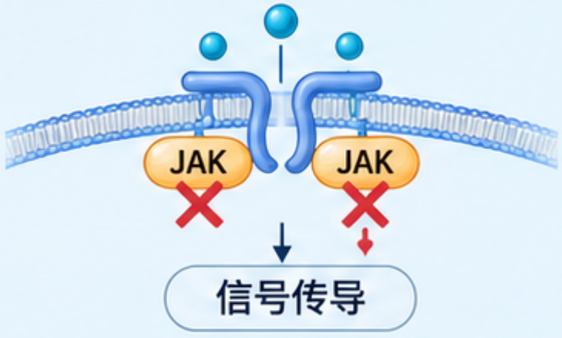
阿巴西普



利妥昔单抗

靶向合成DMARDs

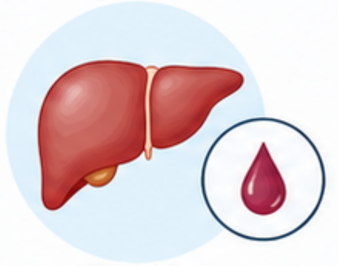
JAK抑制剂



安全与监测要点

用药前评估感染，
筛查结核及乙肝；按药物监测

结核筛查



乙肝筛查

JAK抑制剂：
重视心血管、血栓及肿瘤风险因素

心血管风险

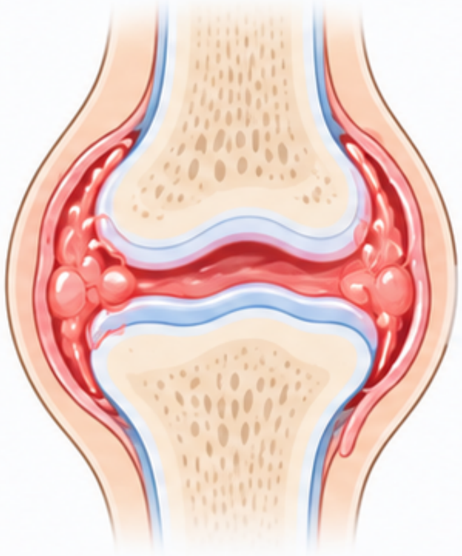
血栓风险

肿瘤风险

回到病例：形成完整诊疗思路

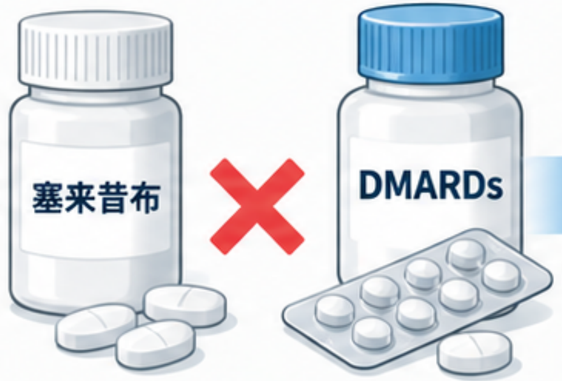
1 病例评估

2 诊断



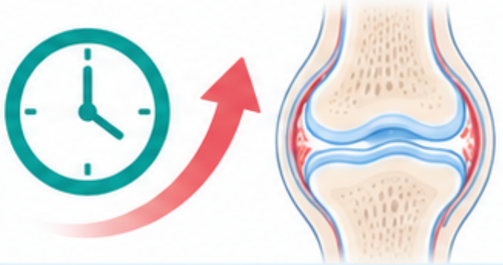
典型炎性关节炎+8分，
结合鉴别诊断

3 治疗



不能只用塞来昔布，
应评估启动适当
DMARDs

4 早治与随访

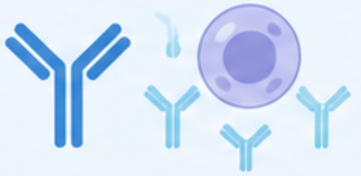


早治：减少持续滑膜炎
造成的不可逆损伤

随访：活动度、功能、
不良反应与依从性

带走五句话

1. RA是慢性全身性自身免疫性疾病



2. 对称性小关节炎与晨僵是重要线索

3. 单项检查不能独立确诊或排除

4. 分类标准不能替代综合临床诊断

5. **早期规范DMARDs，持续达标管理**

课后思考：从识别到管理

1. 典型关节受累特点有哪些？
2. RF阳性为何不能单独诊断RA？
3. 分类标准包括哪四个评分维度？
4. 为什么强调早期使用DMARDs？
5. 各类药物的作用与局限分别是什么？